Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 02

Abdome Agudo e Paracentese

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Abdome agudo e paracentese

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Estabilize, classifique (inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular, hemorrágico), exclua o que não é cirúrgico (ECG, β-hCG), use a TC no adulto e opere peritonite, perfuração, estrangulamento e sangramento; isquemia, com a equipe vascular.

1. **Dor súbita + tábua:** perfuração; radiografia em pé mostra ar sob o diafragma.
2. **Dor desproporcional ao exame:** isquemia mesentérica; angiotomografia.
3. **β-hCG** em toda mulher fértil; ECG no adulto com dor alta.
4. **Analgesia com opioide** não mascara o diagnóstico.
5. Adulto com dor não localizada: TC com contraste; biliar: ultrassom.
6. **Paracentese:** QIE, lateral ao reto, técnica em Z, ultrassom.
7. **GASA ≥ 1,1:** hipertensão portal. **PMN ≥ 250:** tratar como PBE.
8. **Mais de 5 L:** albumina 6–8 g por litro.

Sinais

Sinal	Sugere
Blumberg	Apendicite
Murphy	Colecistite
Jobert	Pneumoperitônio
Cullen	Hemorragia intra-abdominal

Pegadinha

INR alto não impede a paracentese. PBE se trata sem esperar a cultura.

Checklist antes da prova

- ☐ Classifico os cinco tipos
- ☐ Sei os sinais clássicos
- ☐ Lembro do que imita abdome agudo
- ☐ Escolho o exame certo
- ☐ Sei quando operar
- ☐ Sei fazer a paracentese
- ☐ Sei ler GASA e neutrófilos